

РАК ПРЯМОЙ КИШКИ

УДК:616.24-006.6-07

**М.А. Кузикеев, А.Е. Ажмагамбетова, А.И. Джуманов,
С.В. Лашкул, Т.С. Насырtdинов, Г.Т. Сейсенбаева**

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

**Динамика заболеваемости раком прямой кишки в
Северном и Центральном регионе Республики Казахстан**

Аннотация. В статье приведены данные о заболеваемости раком прямой кишки в Северном регионе Республики Казахстан за 2000-2009 гг. Показано, что в изучаемом регионе всего было зарегистрировано 3185 больных раком прямой кишки. В структуре онкологической заболеваемости рак прямой кишки составил 4,3%. Стандартизованный (мировой) по возрасту показатель заболеваемости в регионе зарегистрирован на уровне 8,62 на 100 тысяч населения.

Ключевые слова: рак прямой кишки, заболеваемость, повозрастной показатель.

Актуальность. Рак прямой кишки (РПК) в настоящее время является актуальной проблемой в онкологии, так как ежегодно заболеваемость и смертность от этого недуга неуклонно растет [1,6]. По данным МАИР (Международного агентства по исследованию рака) во всем мире зарегистрировано около 1 миллиона 200 тысяч случаев рака толстой кишки при этом рак прямой кишки составляет почти 30-50% [7]. Учитывая единый механизм возникновения и развития рака ободочной и прямой кишок, имеется одинаковая стратегия лечения и профилактики колоректального рака [1,3]. В большинстве развитых стран мира колоректальный рак занимает 6-8 место в структуре онкологической заболеваемости. Эпидемиологические исследования наиболее полно проведены в высокоразвитых странах мира (США, Канада, Австралия, Северная и Западная Европа), для которых характерны высокие уровни заболеваемости – 30-40 на 100 тысяч населения [4,5]. Для большинства стран Азии показатели заболеваемости не превышают 15-20 на 100 тысяч. Тем не менее, по последним данным в этих странах также наблюдается рост заболеваемости раком толстой кишки [2].

Целью нашего исследования явилось изучение географической вариабельности рака прямой кишки в Казахстане.

Материал и методы исследования. В Северном регионе республики сосредоточены 4 области – Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и г. Астана.

Исследование охватывает период с 2000 по 2009 гг. Материалом исследования служили данные о всех случаях РПК

по информации, предоставляемой специализированными и неспециализированными лечебными учреждениями республики, а также ЗАГС. Для исключения дублирования была проведена алфавитизация массива данных, которые сгруппированы согласно Международной классификации болезней (МКБ-10). В связи с тем, что основным направлением дескриптивной эпидемиологии является изучение пространственных и временных изменений частоты злокачественных опухолей, проведено вычисление прямо или косвенно стандартизованных показателей заболеваемости РПК. Использованы методы графического и пространственного анализа, исследования по картографированию частоты РПК. Каждый зарегистрированный случай РПК был снабжен данными численности общей и половой популяции изучаемого региона. При этом также использованы сведения о численности взрослого населения в возрастных группах (0-29, 30-39...70 и более лет). Информация о каждом случае РПК сопровождается типом лечебного учреждения, где впервые был установлен диагноз. Проведено выявление особенностей в распространении РПК, путем сравнительного изучения соответствующих показателей их частоты. Рассчитаны повозрастные показатели заболеваемости. Стандартизованные показатели заболеваемости определялись прямым методом стандартизации показателей заболеваемости с использованием мирового стандартного населения.

Эпидемиология РПК в Акмолинской области. За указанный период в Акмолинской области зарегистрировано 701 больных РПК, что составило 4% в структуре злокачественных опухолей. Интенсивные показатели заболеваемости с возрастом период имели тенденцию роста. Так, если среди лиц 0-29 лет показатели варьировались с 0,1 до 0,2 на 100 тысяч соответствующей популяции, то в 30-39 лет они были равны 1,3 (оба пола), в 40-49 лет – 6,0 (мужчины) и 7,0 (женщины). В возрасте 50-59 лет показатели заболеваемости у мужчин начинают преобладать (18,2), тогда как у женщин – 14,6.

Первый пик высокой заболеваемости данной локализации в области зарегистрирован среди лиц 60-69 лет мужского населения 58,5 (рисунок 1).

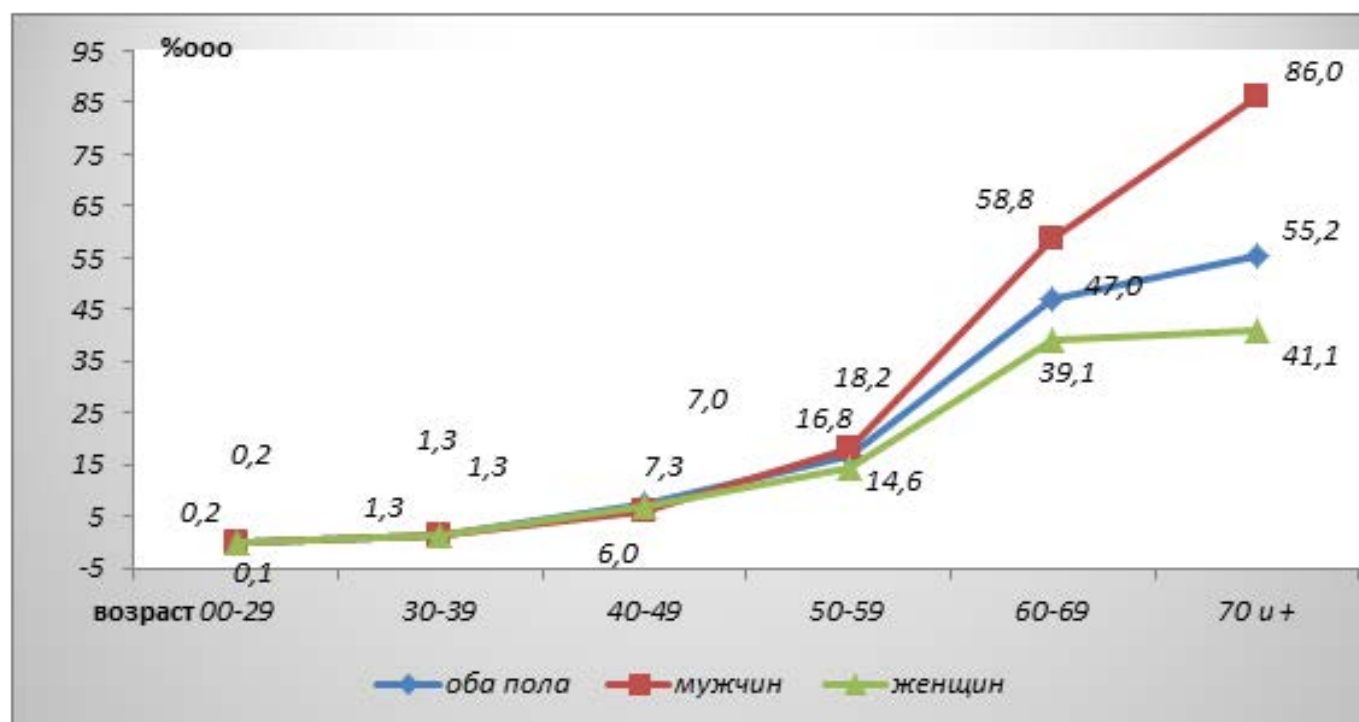


Рисунок 1 – Среднегодовые половозрастные интенсивные показатели заболеваемости раком прямой кишки населения Акмолинской области

Второй пик высокой заболеваемости зарегистрирован также среди мужчин в возрастных группах 70 лет и старше (86,0), тогда как у женщин он был равен 41,1.

Интенсивные показатели заболеваемости РПК в области имеют тенденцию колебания с 10,1 (2000) до 11,1 (2003), с последующим снижением до 9,5 (2007) и 9,21 (2009 г.) ($T_{ин}=0,00\%$) – рисунок 2. Стандартизованные показатели снижаются с 9,3 до 8,0 ($T_{ст}=0,03\%$). Эти данные свидетельствуют, что возрастная структура населения в Акмолинской области не соответствует к мировому стандарту населения.

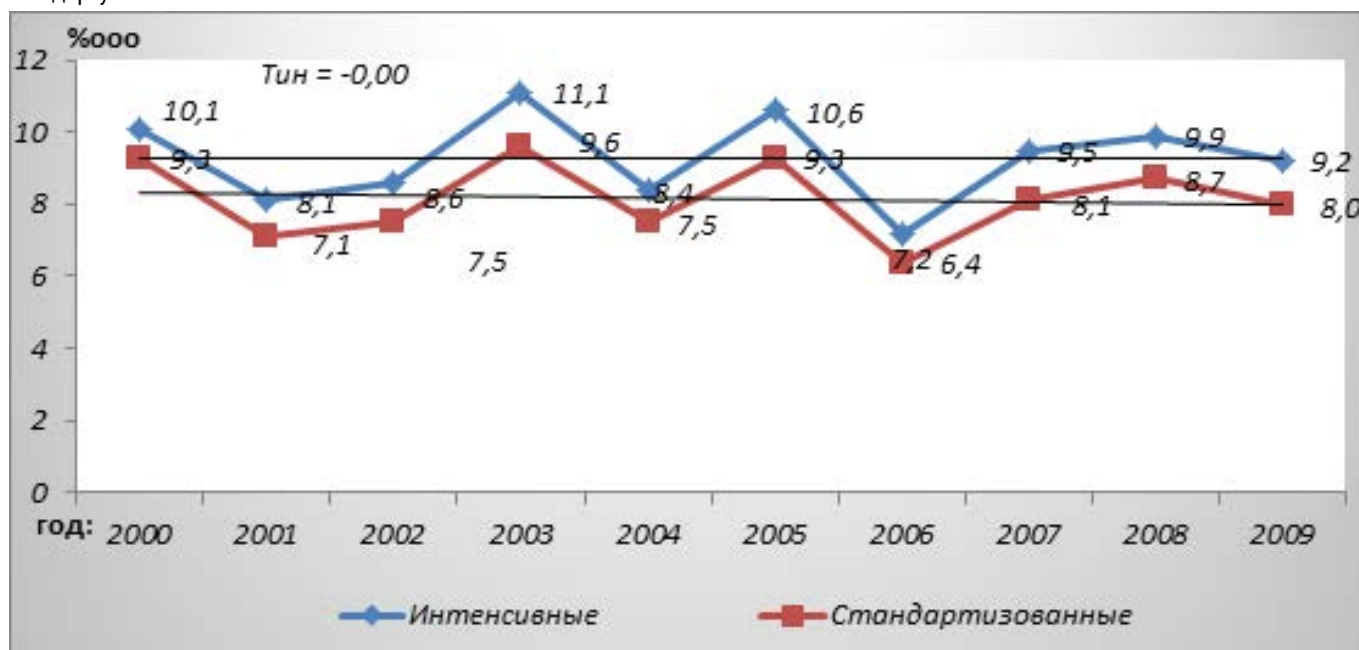


Рисунок 2 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости раком прямой кишки населения Акмолинской области

Среди мужского населения по интенсивным показателям заболеваемости РПК наблюдается картина роста с 8,6 в начале периода до 13,5 (2008 г.) и с последующим снижением до 10,4. Темпы интенсивных ($T_{ин}=0,3$) и стандартизованных ($T_{ст}=0,3$) показателей заболеваемости совпадают. Среди женского населения данные показатели имеют тенденцию колебания с 8,6 (2000 г.) до 12,6 (2008 г.) и с последующим снижением до 10,4 в 2009 г. Удельный вес РПК по возрастным группам имел унимодальный характер роста с пиком в возрастной группе 60-69 лет (37,1%).

Таким образом, общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости РПК составил $9,3 \pm 0,4$, а стандартизованный – $8,1 \pm 0,4$ на 100 тысяч популяции.

Эпидемиология РПК в Карагандинской области. За указанный период зарегистрировано 1201 больных, что составило 3,7% в структуре злокачественных опухолей. По мере увеличения возраста растут показатели заболеваемости – с 0,2 в группе до 30 лет и до 54,9 (оба пола) в группе 70 лет и старше. При этом, наиболее высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в группе 70 лет и старше (89,8 у мужчин и 40,0 у женщин), а также в группе 60-69 лет (60,8 у мужчин и 30,2 у женщин).

Анализ интенсивных показателей в динамике выявил тенденцию к росту с 8,7 до 11,2 к 2007 г. и с некоторым снижением до 9,2 к концу исследования. Стандартизованные показатели у мужчин в динамике имели следующую картину: 11,7, 12,7 и 9,6, соответственно. Темпы соответствовали $T_{ин} = 0,2$ при интенсивном показателе, $T_{ст} = 0,1$ при стандартизации этих показателей заболеваемости. Интенсивные и стандартизованные показатели за этот период в динамике выросли с 8,1 до 9,2 на 100 тысяч.

Удельный вес РПК по возрастным группам имел унимодальный характер роста с пиком в возрастной группе 60-69 лет (36,2%), тогда как у мужчин он составил 38,4%, а у женщин 34,0%. Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости РПК зарегистрирован на уровне $8,9 \pm 0,5$, стандартизованный – $7,8 \pm 0,5$ на 100 тысяч населения.

Эпидемиология РПК в Костанайской области. За период исследования по области зарегистрировано 1112 больных РПК (5,0%). С возрастом показатели заболеваемости имели тенденцию к росту. Низкие показатели отмечены в возрасте до 50 лет, когда значения для лиц обоего пола не достигали 20 на 100 тысяч. Заметный рост показателей заболеваемости РПК наблюдается среди лиц 50-59 лет (24,2 у мужчин и 21,2 у женщин). Высокие уровни зарегистрированы в группах 60-69 и 70-79 лет (59,0 и 69,0, соответственно – оба пола). Причем у мужчин в 70-79 лет отмечен самый высокий уровень – 105,7 на 100 тысяч соответствующей популяции.

Динамика заболеваемости показала колебания показателей – подъем с 11,5 до 14,0 и вновь падение до 11,5. Среди мужчин тенденция была следующей – 13,4, 15,8 и 11,0. У женщин также наблюдается некоторое снижение показателей с 13,3 до 12,0 на 100 тысяч.

Таким образом, удельный вес РПК характеризуется высокой долей в возрастных группах 60-69 лет (35,3%) и имеет унимодальный характер роста. Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости составил $12,1 \pm 0,4$, стандартизованный (мировой) – $9,6 \pm 0,4$.

Эпидемиология РПК в Северо-Казахстанской области. Зарегистрировано 776 больных РПК или 4,6% в общей структуре опухолей. Среди лиц 0-29 лет данные показатели, как у мужчин, так и женщин занимали одинаковые позиции (0,2). В группе 30-39 лет показатели были на уровне 1,3-3,1. В возрастных группах 40-49 лет эти данные были высокими среди мужского населения (7,4) по сравнению с женщинами (5,1). Заметный рост показателей заболеваемости РПК наблюдается среди лиц 50-59 лет (20,5 у мужчин и 19,0 у женщин). Высокие уровни зарегистрированы в следующих возрастных

группах (60-69 и 70 лет и старше) – 57,2 и 58,6 (оба пола), соответственно. При этом показатели у мужчин превышали аналогичные у женщин почти в два раза.

Тренды интенсивных показателей имеют тенденцию роста с 9,1 до 11,9, причем более выраженные у мужчин. Динамика стандартизованных показателей заболеваемости у мужчин в целом имела тенденцию роста. Наибольший пик заболеваемости данной локализации наблюдается в 2006 году (15,7). Стандартизованные показатели выросли до 16,1 в данном году с последующим снижением до 13,7 в конце исследования. Темпы интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости совпадают. Возрастной состав мужского населения области соответствует составу принятого за мировой стандарт. Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости женского населения области за этот период в динамике выросли с 9,5 до 14,5 в 2005 году, а в конце исследуемого периода отмечается снижение до 10,1. В целом, среднегодовой интенсивный показатель составил $11,6 \pm 0,7$, стандартизованный (мировой) – $9,3 \pm 0,6$.

В динамике интенсивные показатели (оба пола) имели тенденцию снижения, хотя вначале отмечался рост с 9,3 до 9,8 в 2005 г., и в конце исследования данный показатель идет на снижение (7,7). Темпы интенсивных ($T_{ин} = -0,1\%$) и стандартизованных ($T_{ст} = -0,1\%$) показателей совпадают. Анализ динамики показателей в зависимости от пола выявил примерно такие же тенденции. В целом, общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости РПК составил $7,5 \pm 0,4$, стандартизованный (мировой) – $8,8 \pm 0,4$.

Эпидемиология РПК в г. Астане. За 10-летний период в г.Астане зарегистрировано 395 больных РПК, что составляет в структуре злокачественных опухолей 4,0%. Повозрастные показатели заболеваемости имели тенденцию к росту с 0,2-0,3 в группе 0-29 лет, до 0,9-1,1 в группе 30-39 лет. В возрастных группах 40-49 лет эти данные были высокими среди женского населения (4,6) по сравнению с показателями среди мужчин (1,2). Начиная с 50 лет, показатели у мужчин начинают превалировать. Высокая заболеваемость данной локализации отмечена среди лиц 60-69 лет: у мужского населения – 65,5, среди женщин – 38,4. В группе 70 лет + показатели наиболее высоки и у мужчин (112,2) и у женщин (60,8). Таким образом, общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости рака прямой кишки составил $7,5 \pm 0,4$, стандартизованный (мировой) – $8,8 \pm 0,4$.

Заключение. Таким образом, в Северо-Центральном регионе за 10 лет было зарегистрировано 3185 пациентов раком прямой кишки, что составило 4,3% в структуре общей онкологической заболеваемости. Среднегодовой показатель заболеваемости в целом по региону составил 9,06, а стандартизованный 8,62 на 100 тысяч населения. Отмечаются определенные половозрастные особенности в распространении и динамике интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости раком прямой кишки. Относительно высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастных группах 50-59, 60-69 и 70 лет и старше. Географические различия в распространении рака прямой кишки обусловлены возрастным, этническим составом и неравномерным воздействием факторов окружающей среды, что требует продолжения эпидемиологических аналитических исследований.

Список литературы

1. Аксель Е.М., Ушакова Т.П. Заболеваемость и смертность от рака прямой кишки. Новое в терапии колоректального рака /Под ред. проф. Н.И. Переводчиковой. – М., 2001. – С.6-9.
2. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009 год (статистические материалы). – Алматы, 2010. – 85 с.
3. Bartsch H., Nietanen E. The role of individual susceptibility in cancer burden related to environmental exposure //Environ Health Perspect. – 2006. – Vol. 104 (Suppl 3). – P.569-77.
4. Markowitz S.D., Bertagnolli M.M. Molecular basis of colorectal cancer //N. Engl. J. Med. – 2009. – Vol.361 (25). – P.2449–60.
5. Hunter D.J., Spiegelman D. Dietary Fiber and Colorectal Cancer: An Ongoing Saga //Journal of the American Medical Association. – 2005. – Vol.294 (22). – P.2904–6.
6. Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J. et al. (eds). Cancer Incidence in Five Continents. Vol. VIII, IARC Scientific Publications No. 155. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2002.
7. Parkin D.M. et al. Age-standardized Incidence Rates for Colorectal Cancer //CA Cancer J. Clin. – 2005. – Vol.55. – P.74-108.

ТҰЖЫРЫМ

М.А. Кузикеев, А.Е. Азмагамбетова, А.И. Джуманов, С.В. Лашкул, Т.С. Насрытдинов, Сейсенбаева Г.Т.

Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институты

Қазақстан Республикасы Солтүстік және Орталық өңірлерде тік ішектің қатерлі ісігіне динамикасы

Бұл мақалада 2000-2009 жылдары Қазақстан Республикасының солтүстік өңірде тік ішектің қатерлі ісігінің таралуы туралы деректер берілген. Бұл зерттелген аймақтағы тік ішек обырымен 3185 науқас тіркелген деп көрсетілген. Онкологиялық аурудың құрылымында, тік ішектің қатерлі ісігі 4,3%-ды құрады. Жас бойынша стандартталған (әлемдік) аймақтағы ауру көрсеткіші 100 тұрғынға шаққанда 8.62 мың халықтың деңгейінде тіркелді.

Түінді сөздер: тік ішектің қатерлі ісігі, заболеваемость, по возрастной показатель.

SUMMARY

M.A. Kuzikeev, A.Y. Azhmagambetova, A.I. Jumanov, S.V. Lashkul, T.S. Nasrytdinov, G.T. Seysenbayeva
Kazakh Institute of Oncology and Radiology

The dynamics of the incidence of the rectum cancer in Northern and Central regions of the Republic of Kazakhstan

In this article presented the rectal cancer incidence at the North region of Kazakhstan during 2000-2009. There were registered 3185 cases with a new diagnosis of rectal cancer or 4.3% in the whole malignant tumors incidence. Total cancer incidence (world standard) was 8.62 per 100 000 of population.

Keywords: rectal cancer, incidence, age-standardized rate.